Québec
Santé Québec

DT9002

Demande de service
HÉMODYNAMIE (ADULTE)

*** Champs obligatoires**

Renseignements de base

***Provenance du patient :** ☐ Domicile ☐ Hospitalisé au CH référant (Transfert) ☐ Interne

Date de non-disponibilité : Du — Année / Mois / Jour — Au — Année / Mois / Jour — Raison

Médecin référant

*Nom (en lettres moulées) | Spécialité | N° permis

*Établissement | Installation | Ind. rég. | N° de téléphone | N° de poste | Ind. rég. | N° de télécopieur

Référé ☐ au service ☐ au Dr | **Signature** | **Date** — Année / Mois / Jour

Infection/porteur

☐ SARM[i]+ ☐ ERV[ii] ☐ Autre

Pontage coronarien antérieur

☐ Oui | **Date** — Année / Mois / Jour | Lieu | Rapport obligatoire ☐ Inclus ☐ Suivra

*Intervention demandée

☐ Coronarographie
☐ Coronarographie ± Angioplastie
☐ Révision pontage coronarien
☐ Angioplastie
☐ Étude physiologique coronarienne
☐ Cathétérisme droit
☐ Biopsie myocardique
☐ Cathétérisme D/G
☐ Fermeture d'appendice auriculaire
☐ Valvuloplastie
☐ Intervention valvulaire percutanée :
☐ Fermeture CIA[iii] /FO
☐ Clip mitral
☐ TAVI[iv]
☐ Clip tricuspide
☐ Autre :

Commentaires :

*Classification fonctionnelle (CMQ[v] - RQCT[vi])

☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV-A ☐ IV-B ☐ IV-C1 ☐ IV-C2

*Renseignements cliniques

Maladie coronarienne :	☐ STEMI[vii]	☐ NSTEMI[viii] / AI	☐ Angine stable	☐ Ischémie silencieuse
Infarctus du myocarde :	☐ Aigu	☐ < 1 semaine	☐ < 3 mois	☐ > 3 mois
Sténose valvulaire :	☐ Aortique	☐ Mitrale	☐ Pulmonaire	☐ Tricuspidienne
Insuffisance valvulaire :	☐ Aortique	☐ Mitrale	☐ Pulmonaire	☐ Tricuspidienne
Maladie congénitale :	☐ CIA	☐ FOP[ix]	☐ Autre :	

☐ Syndrome vasculaire aigu ☐ Syndrome vasculaire stable

Pouls radial présent : ☐ Droit ☐ Gauche Pouls fémoral présent : ☐ Droit ☐ Gauche

☐ **Défaillance cardiaque** ☐ **Hypertension artérielle pulmonaire** ☐ **Cardiopathie hypertrophique**

Commentaires :

Créatinine : µmol/L ☐ Dialyse

☐ Diabète : traitement : ☐ Diète ☐ Hypoglycémiants oraux ☐ Insuline Poids (kg) : ☐ Autre :

Résultats de tests non invasifs réalisés

☐ ECG au repos – changements ischémiques récidivants :
☐ Épreuve d'effort positive : <5 Mets ou chute T.A.
☐ Scintigraphie myocardique – Ischémie antérieure ou plusieurs zones ischémiques
Fraction d'éjection : % ☐ inconnue Source : ☐ Échographie ☐ Angiographie ☐ Méthode isotopique
☐ IRM cardiaque
☐ Troponine +
☐ Autre

Médication

☐ Acide acétylsalicylique (ASA) ☐ Prasugrel ☐ Warfarine ☐ Autre :
☐ Antagonistes des récepteurs GP IIB ☐ Ticagrelor ☐ Héparine standard
☐ Clopidogrel ☐ Anticoagulants oraux directs ☐ Héparine de bas poids moléculaire (HBPM)

Allergies

☐ Iode ☐ Latex ☐ ASA ☐ Clopidogrel ☐ Autre : ☐ Aucune connue

Résumé de dossier

☐ Inclus ☐ Suivra

Projet de recherche

Nom : Type : ☐ Thérapeutique ☐ Contrôle
Commentaires :

Remarques

Réception de la demande à l'établissement receveur

Nom de l'établissement | Signature de la personne autorisée à traiter cette demande | **Date** — Année / Mois / Jour

Classification fonctionnelle **(CMQ – RQCT)**	
Classe	Description
I	Asymptomatique ou limitation apparaissant aux efforts violents, prolongés et inhabituels.
II	Limitation légère lors d'activité régulière. La limitation peut survenir à la marche ou à la montée d'escaliers.
III	Limitation marquée lors des activités régulières.
IV-A	Limitation sévère ou état instable maintenant stabilisé avec une médication orale.
IV-B	Limitation sévère ou état instable. La limitation persiste lors d'activités légères ou au repos malgré le traitement médical optimal. Ne nécessite pas de thérapie intraveineuse.
IV-C1	Limitation sévère ou état instable réfractaire au traitement médical optimal et nécessitant une thérapie intraveineuse.
IV-C2	Limitation sévère ou état instable nécessitant une thérapie intraveineuse et demeurant en instabilité hémodynamique ou rythmique malgré celle-ci. Inclut aussi l'angioplastie primaire et de sauvetage dans l'infarctus du myocarde ainsi que la dissection aortique et la rupture d'anévrisme.

Accessibilité en hémodynamie – classification par priorité (RQCT)					
Info. Clinique	**Classe Fonct. (RQCT)**	**Niveau de risque**	**Diagnostic**	**Priorité**	**Délais**
Coronarien			Syndrome coronarien aigu avec instabilité hémodynamique ou rythmique	1	Immédiat
Coronarien	IV-C2	NA	Angioplastie primaire ou de sauvetage dans l'infarctus du myocarde	1	Immédiat
Valvulaire			Syndrome valvulaire aigu avec instabilité hémodynamique ou rythmique	1	Immédiat
Vasculaire			Syndrome vasculaire aigu	1	Immédiat
Coronarien			Syndrome coronarien aigu réfractaire au traitement médical optimal incluant une thérapie intraveineuse	2	< = 24 heures
Valvulaire	IV-C1	NA	Syndrome valvulaire sévère réfractaire au traitement médical optimal incluant une thérapie intraveineuse	2	< = 24 heures
Coronarien			Syndrome coronarien aigu amélioré avec un traitement médical optimal mais persistant à l'effort minimum	3.1	< = 72 heures
Valvulaire	IV-B	NA	Syndrome valvulaire sévère amélioré avec un traitement médical optimal mais persistant à l'effort minimum sans thérapie intraveineuse	3.1	< = 72 heures
Coronarien		Haut risque	Syndrome coronarien aigu stabilisé avec une médication orale, haut risque	3.2	< = 1 semaine
Valvulaire	IV-A	NA	Syndrome valvulaire sévère symptomatique stabilisé	3.2	< = 1 semaine
Cononarien		Bas risque	Syndrome coronarien aigu stabilisé avec une médication orale, bas risque	4	< = 2 semaine
Coronarien		Haut risque	Syndrome coronarien haut risque	4	< = 2 semaines
Valvulaire	III	NA	Syndrome valvulaire stable	4	< = 2 semaines
Cononarien		Bas risque	Syndrome coronarien bas risque	5.1	< = 1 mois
Coronarien		Haut risque	Syndrome coronarien haut risque	5.1	< = 1 mois
Valvulaire	II	NA	Syndrome valvulaire stable	5.1	< = 1 mois
Cononarien		Bas risque	Syndrome coronarien bas risque	5.2	< = 2 mois
Coronarien		Haut risque	Syndrome coronarien haut risque	5.1	< = 1 mois
Valvulaire	I	NA	Syndrome valvulaire stable	5.1	< = 1 mois
Cononarien		Bas risque	Syndrome coronarien bas risque	5.2	< = 2 mois
Vasculaire	NA	NA	Syndrome vasculaire stable	5.2	< = 2 mois
Maladie congénitale	NA	NA	Communication inter auriculaire (CIA) Foramen ovale perméable (FOP)	6	< = 3 mois

Note : Les résultats de tests non-invasifs réalisés servent à définir les variables de « haut risque » et de « bas risque ». Ainsi, la notion de patient à haut risque de complications cardiovasculaires vient pondérer, avec les autres informations cliniques, le niveau de priorité du patient. Le patient sera à haut risque dès que l'un des résultats de tests non-invasifs est positif ou que la fraction d'éjection ventriculaire gauche est plus petite ou égale à 40 %.

[i] SARM : Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
[ii] ERV : Entérocoques résistant à la vancomycine
[iii] CIA : Communication inter auriculaire
[iv] TAVI : *Transcatheter Aortic Valve Implantation* (implantation de valve aortique par voie percutanée)
[v] CMQ : Collège des médecins du Québec
[vi] RQCT : Réseau québécois de cardiologie tertiaire
[vii] STEMI : *ST segment elevation myocardial infarction* (infarctus du myocarde avec élévation du segment ST)
[viii] NSTEMI : *Non ST segment elevation myocardial infarction* (infarctus du myocarde sans élévation du segment ST)
[ix] FOP : Foramen ovale perméable
RQCT : Réseau québécois de cardiologie tertiaire
CMQ : Collège des médecins du Québec